

TEMA 3.34 • OBSTETRICIA

Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial

PERFIL EUNACOM 1.03.34
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial

Causa Común

Todas las complicaciones exclusivas de los monocoriales se producen por la existencia de **vasos placentarios comunicantes** entre las circulaciones de ambos fetos.

1. Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF)

Fisiopatología: Sangre fluye en una dirección: de un gemelo (**donante**) al otro (**receptor**).

TABLA 3.34.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	GEMELO DONANTE	GEMELO RECEPTOR
Líquido amniótico	Oligoamnios	Polihidramnios
Vejiga	Vacía	Llena
Doppler ACM	Velocidad ↑ (anemia)	Velocidad ↓ (policitemia)
Riesgo	Anemia grave	Insuficiencia cardíaca

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ambos fetos están en riesgo — no solo el donante. El receptor puede morir de insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen.

- **Tratamiento:**
 - **Ablación láser** de vasos comunicantes (fetoscopia) → tratamiento definitivo — cambia dramáticamente el pronóstico
 - **Amnioreducción** del gemelo con polihidramnios → alternativa paliativa, menos compleja
- Luego del tratamiento → manejo como gemelar biamniótico corriente → interrupción 36–37 semanas.

2. Síndrome de Anemia-Policitemia (TAPS)

- Similar al STFF pero de menor severidad
- Anemia en un gemelo + policitemia en el otro
- **Tratamiento:** Generalmente observación; en casos graves: ablación láser o amnioreducción

3. Secuencia TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion)

- **Fisiopatología:**
- **Gemelo acardio** → no tiene corazón (a veces ni cabeza) → incompatible con la vida

- **Gemelo bomba** → tiene corazón normal, pero bombea para dos → riesgo de insuficiencia cardíaca
- Diagnóstico:** Doppler — ausencia de actividad cardíaca en un gemelo; signos de IC en el otro.
- Tratamiento:** **Oclusión del cordón umbilical del gemelo acardio** (láser, radiofrecuencia o electrobisturí) → Se asegura el fallecimiento del acardio (que era inviable) y se protege al gemelo bomba.

4. Entrelazamiento de Cordones

Solo en monoamnióticos — ambos cordones están en el mismo espacio amniótico y pueden enredarse.

TABLA 3.34.2: CONSECUENCIA VS MECANISMO	
CONSECUENCIA	MECANISMO
Isquemia fetal	Oclusión intermitente del cordón
Muerte fetal	Oclusión sostenida
Secuelas neurológicas	Hipoxia intermitente

Manejo: - **Hospitalización desde las 26 semanas** - Monitorización fetal frecuente (RBNS diario) - **Interrupción a las 32–34 semanas** (siempre por cesárea)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"En relación a Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial: Luego del tratamiento → manejo como gemelar biamniótico corriente → interrupción... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa Común
- 1. Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF)
- 2. Síndrome de Anemia-Policitemia (TAPS)
- 3. Secuencia TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion)
- 4. Entrelazamiento de Cordones
- vasos placentarios comunicantes
- Ambos fetos están en riesgo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES DEL EMBARAZO GEMELAR MONOCORIAL)**PREGUNTA 1**

En relación a Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial: Luego del tratamiento → manejo como gemelar biamniótico corriente → interrupción... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Complicaciones del Embarazo Gemelar Monocorial. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: COMPLICACIONES DEL EMBARAZO GEMELAR MONOCORIAL

Todas las complicaciones exclusivas de los monocoriales se producen por la existencia de vasos placentarios comunicantes entre las circulaciones de ambos fetos. ::warning Ambos fetos están en riesgo — no solo el donante. El receptor puede morir de insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen. ::info Tratamiento: Oclusión del cordón umbilical del gemelo acardio (láser, radiofrecuencia o electrobisturí) → Se asegura el fallecimiento del acardio (que era inviable) y se protege al gemelo bomba.